

TEMA 3.11 • OBSTETRICIA

Óbito Fetal

PERFIL EUNACOM 2.01.2.009
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Óbito Fetal

Definición

Muerte fetal intrauterina ≥ 22 semanas (o ≥ 20 sem + 6 días según definición moderna).

Clínica

- Habitualmente **asintomático** (hallazgo o confirmación ecográfica)
- A veces: referencia de disminución de movimientos fetales
- La clínica sola tiene muy mal rendimiento — se requiere ecografía

Diagnóstico

Ecografía: ausencia de latidos cardíacos fetales en feto ≥ 22 semanas.

Manejo

Evacuación (recomendada en la mayoría)

- Vía: Parto vaginal** (regla general)
- Inducción con misoprostol + oxitocina (dilatación mecánica previa si necesario)
- Cesárea está contraindicada** en óbito fetal — mayor riesgo materno sin beneficio fetal

Conducta expectante (excepcional)

- Solo casos muy seleccionados (paciente lo solicita / contraindicación específica)
- Máximo ~2 semanas (inicio espontáneo del trabajo de parto)
- Riesgo: CID** (coagulación intravascular diseminada) → complicación grave, incluso letal

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La mayoría de las guías recomienda **interrumpir siempre** por el riesgo de CID. La observación es una excepción, no la norma.

Medidas Siempre

- Autopsia fetal** — la muerte fetal > 22 sem no es frecuente; buscar genopatías, infecciones, causa
- Contención emocional** — ofrecer ver al bebé, despedirse, apoyo psicológico posterior
- ROGAM** si madre Rh negativo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Óbito Fetal: Óbito Fetal ## Definición Muerte fetal intrauterina ≥ 22 semanas (o ≥ 20 sem +... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Óbito Fetal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Clínica
- Diagnóstico
- Manejo
- Evacuación (recomendada en la mayoría)
- Conducta expectante (excepcional)
- Medidas Siempre

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ÓBITO FETAL)

PREGUNTA 1

En relación a Óbito Fetal: Óbito Fetal ## Definición Muerte fetal intrauterina ≥ 22 semanas (o ≥ 20 sem +... ¿cuál es la conducta correcta?

- A) El diagnóstico de Óbito Fetal se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Óbito Fetal debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Óbito Fetal requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Óbito Fetal es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Óbito Fetal no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Óbito Fetal?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Óbito Fetal. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ÓBITO FETAL

:::warning La mayoría de las guías recomienda interrumpir siempre por el riesgo de CID. La observación es una excepción, no la norma.
:::